

سلس البول الإجهادي (SUI) عند الرجال يعني تسرّب البول عندما يحدث شيء ضغطاً مفاجئاً على المثانة — كالسعال أو الوقوف أو رفع الأشياء أو النشاط البدني. وفي الغالب يكون سببه ضعف العضلة المتحكّمة في البول (العضلة العاصرة) بعد جراحة البروستاتا أو الإشعاع. كثيراً ما تتحسنّ الحالة خلال السنة الأولى، وإذا لم تتحسنّ فهناك علاجات فعالة جداً.

عن هذه الحالة

بعد استئصال البروستاتا، تتولّى **العضلة العاصرة للإحليل** (الصمام الذي يحبس البول) الجزء الأكبر من العمل، وقد تكون ضعيفة. والنتيجة هي التسرّب عند المجهود — من قطرات قليلة تستلزم فوطه، إلى تسرّب أكثر غزارة. يختلف هذا عن السلس **الإلحاحي** (رغبة مفاجئة وعاجلة في التبول)، الذي يُعالج بطريقة مختلفة؛ وقد يعاني بعض الرجال من النوعين معاً.

الأسباب

- استئصال البروستاتا الجذري (إزالة البروستاتا لعلاج السرطان) — السبب الأكثر شيوعاً
 - إجراءات البروستاتا الأخرى أو الإشعاع **الحوضي**
 - في حالات أقل: اضطرابات الأعصاب أو المثانة
- يكون التسرّب عادةً **أشدّ في البداية** ثم يتحسنّ تدريجياً مع التنام الأنسجة واستعادة قوة قاع الحوض.

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرّب البول مع الضغط — السعال أو الوقوف أو رفع الأشياء.

العضلة العاصرة

الصمام العضلي الذي يحبس البول حتى تقرر التبول.

استئصال البروستاتا

جراحة إزالة البروستاتا، وهي السبب المعتاد لـ SUI عند الرجال.

قاع الحوض

العضلات التي تُدرّب لتحسين التحكم في البول.

اختبار الفوطه

عدّ الفوط يومياً لقياس كمية التسرّب.

الحبال الذكورية (sling)

دعامة توضع أسفل الإحليل لعلاج التسرّب الخفيف إلى المتوسط.

بالونات ProACT

بالونان قابلان للضغط يُوضعان بجانب الإحليل ويُعدّلان في العيادة؛ خيار طفيف التدخل.

العضلة العاصرة البولية الاصطناعية

جهاز مزروع (كُفّة يتحكّم بها المريض) للتسرّب المتوسط إلى الشديد.

هل ستتُحسن الحالة؟ في الغالب نعم — يتُحسن التسرّب بعد جراحة البروستاتا عادةً خلال 6-12 شهراً، خاصةً مع تمارين قاع الحوض. إذا استمر التسرّب المزجج أكثر من عام، فعندها يُناقش الحبال الذكوري أو البالونات القابلة للضغط أو العضلة العاصرة الاصطناعية — وجميعها فعّالة جداً.

كيف تُشخّص

- مناقشة متى وكم تتسرّب (يُقاس في الغالب بـ عدد الفوط يومياً)
- فحص البول والتحقّق من مدى إفراغ المثانة بالكامل
- قبل الجراحة: تنظير الإحليل (تنظير المثانة) وأحياناً اختبار وظائف المثانة

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

- 1 تمارين قاع الحوض (كيجل)، يُفضّل البدء بها قرب وقت الجراحة، مع ضبط السوائل والوزن.
- 2 متابعة التحسّن خلال السنة الأولى، مع استخدام الفوط أو الحواجز الواقية حسب الحاجة.
- 3 الحبال الذكورية (male sling) — للتسرّب الخفيف إلى المتوسط المستمر (دون إجراءات علاجية سابقة).
- 4 بالونات ProACT القابلة للضغط — خيار آخر طفيف التداخل للتسرّب الخفيف إلى المتوسط؛ يُضبط بالونان صغيران في العيادة على عدة زيارات (لا يُستخدم بعد الإشعاع).
- 5 العضلة العاصرة البولية الاصطناعية (AUS) — المعيار الذهبي للتسرّب المتوسط إلى الشديد، والخيار المفضّل بعد الإشعاع. لكلّ منها نشرة خاصة.

التعايش مع SUI الذكوري

- مارس تمارين قاع الحوض بانتظام — فهي الأساس.
- استخدم الفوط أو الملابس الواقية لاسترداد ثقتك أثناء التعافي.
- قلّل السوائل والكافيين مساءً إذا كان التسرّب الليلي مشكلة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حرقّة، أو حمّى، أو دم في البول (قد تكون عدوى)
- عجز مفاجئ عن التبوّل
- تسرّب يزداد سوءاً بدلاً من التحسّن

ثلاثة أمور تُدكّرُها

1. SUI الذكوري سببه في الغالب ضعف العضلة العاصرة بعد جراحة البروستاتا أو الإشعاع — وعادةً يتُحسن خلال السنة الأولى.
2. تمارين قاع الحوض هي الأساس؛ وللتسرّب المستمر، يُعطي الحبال الذكوري أو العضلة العاصرة الاصطناعية نتائج ممتازة.
3. أعط نفسك حتّى عام كامل قبل اتخاذ قرار الجراحة. اتصل بفريقك عند الحمّى، أو الدم في البول، أو تعذّر التبوّل.